CM2 Nature et qualité des données

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Cours et application

Donnée et indice

Une donnée est une information recueillie sur une personne. Un indice clinique est une donnée qui oriente une hypothèse à vérifier. Un signe est observé ou mesuré ; un symptôme est rapporté par la personne. Un indice isolé ne suffit pas à poser un diagnostic.

Deux axes de classement

Objectif et subjectif décrivent la provenance ou la nature du constat. Quantitatif et qualitatif décrivent sa forme. Ces axes se croisent : une douleur cotée 6 sur 10 est subjective et quantitative. La parole du patient reste une donnée clinique à part entière.

Qualité du recueil

Identifier qui rapporte, quand, où et dans quelles conditions. Comparer à l'état habituel et aux données antérieures. Une mesure isolée sans contexte peut être trompeuse ; rechercher les autres signes et vérifier les conditions de mesure.

Pertinence et signal faible

Recueillir ce qui éclaire la question clinique et peut modifier la surveillance ou l'action. Une baisse inhabituelle des apports ou une modification discrète du comportement peut justifier des vérifications, même sans anomalie spectaculaire.

Outil et traçabilité

Choisir une échelle selon le phénomène, la population, sa validation et le contexte. Tracer les faits et les propos exacts utiles, l'heure, les actions et la réponse. Éviter les jugements tels que « pénible » ; décrire le comportement observé.

Application

Une personne auparavant autonome mange moins et reste assise. Décrire le changement sans conclure immédiatement à une dépression. Rechercher douleur, fatigue, difficultés alimentaires, contexte relationnel et évolution, puis transmettre les éléments significatifs.

Construire une donnée exploitable

Le recueil commence par une question clinique. Rechercher tout sans hiérarchie peut noyer les informations importantes. Le but est de comprendre l'état actuel, de connaître les capacités habituelles et d'identifier ce qui change. Une information peut devenir pertinente plus tard lorsque la situation évolue.

Pour une mesure, préciser le paramètre, la valeur, l'unité, la date, l'heure et les conditions utiles. Une pression artérielle se lit avec le contexte, les symptômes et les mesures précédentes. Vérifier les conditions techniques si le résultat surprend, sans retarder une alerte devant une situation préoccupante.

Pour une donnée rapportée, identifier la source : patient, proche ou professionnel. Utiliser les propos exacts lorsqu'ils éclairent le vécu. Un ressenti reste cliniquement important même s'il n'est pas mesurable directement par un appareil. Décrire aussi les limites du recueil, notamment une difficulté de communication.

Les classements sont complémentaires. Une douleur chiffrée par le patient est subjective par sa source et quantitative par sa forme. Une observation de posture est objective au sens descriptif mais qualitative. Le caractère objectif d'un fait ne garantit pas l'exactitude de l'interprétation qui en est tirée.

Du signal à l’hypothèse

Un indice attire l’attention parce qu’il peut orienter le raisonnement. Sa valeur dépend de l’intensité, de la temporalité, du contexte et de l’évolution. Rechercher les liens entre plusieurs données plutôt que compter chaque indice comme une preuve indépendante.

Le signal faible correspond à un changement discret susceptible d’avoir une signification clinique. Le reconnaître suppose de connaître l’état habituel et de comparer dans le temps. Une réduction des apports ou un retrait inhabituel peut être significatif même si la température reste normale.

Dans le mini-cas des notes, la personne auparavant autonome mange moins et reste assise. Il faut préciser depuis quand, ce qu’elle dit, ses douleurs, son sommeil, sa fatigue et ses possibilités de se déplacer. Le même comportement peut avoir plusieurs causes ; ne pas conclure d’emblée à un diagnostic psychologique.

Formuler une hypothèse guide ce qu’il faut vérifier. Chercher aussi les éléments qui pourraient la contredire et les autres explications possibles. La démarche est évolutive : une donnée nouvelle peut modifier la surveillance, l’ordre des priorités et les actions. La continuité des transmissions permet à l’équipe de suivre ce raisonnement.

Choisir un outil et rendre le raisonnement partageable

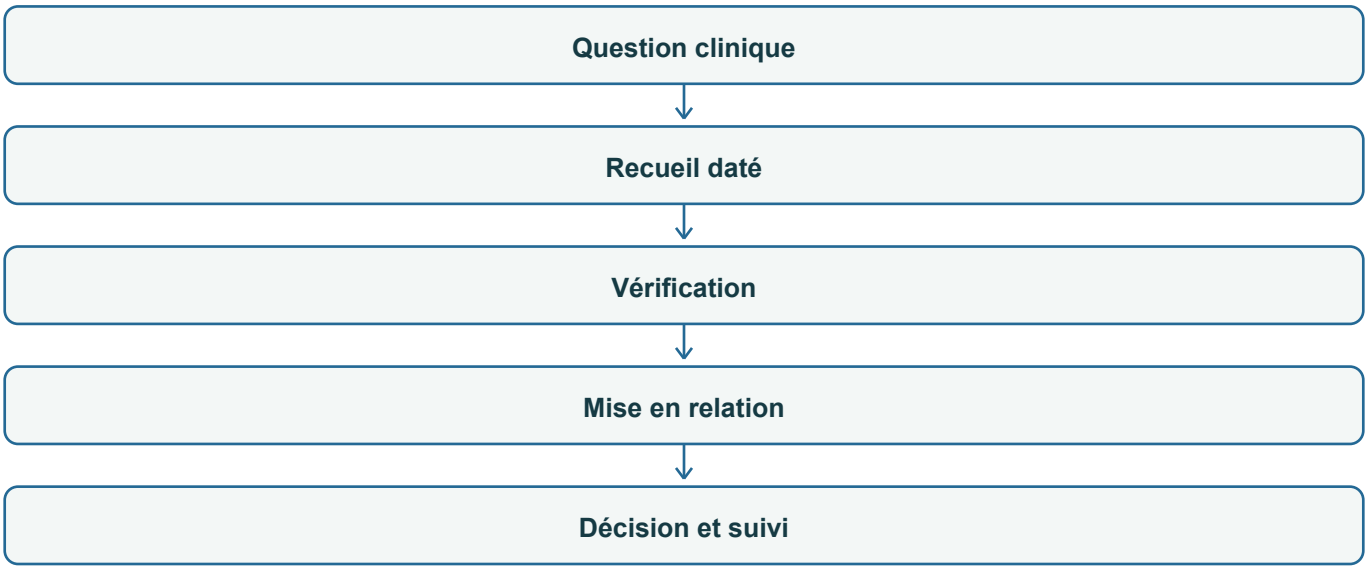
Une échelle est choisie à partir du phénomène à évaluer, de la population et du contexte. Examiner ce que mesure l'outil, les conditions de sa validation et ses consignes. Un outil pratique mais inadapté à la communication ou à l'état clinique peut produire un résultat trompeur.

La cotation doit être liée à une utilisation clinique : repérer un risque, suivre une évolution ou apprécier une intervention. Un score n'est pas une décision automatique. Il faut préciser les observations associées, les limites et les actions qui en découlent.

Dans les écrits, décrire avant d'interpréter. Préférer « repousse le matériel et dit ne pas vouloir le soin maintenant » à « patient non coopérant ». La première formulation permet de rechercher la cause, de distinguer fait et interprétation et de construire une réponse respectueuse.

Une transmission utile permet de comprendre ce qui a changé, ce qui a été fait et la réponse observée. Elle est datée et attribuable. Les informations pertinentes sont réévaluées au fil de la prise en charge ; le dossier soutient la coordination clinique, et non seulement une obligation administrative.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Une EN à 6 sur 10 est-elle objective ? Non : l’intensité est déclarée par le patient.

Une donnée normale écarte-t-elle tout problème ? Non : elle s’interprète avec le contexte et l’évolution.

Que faire d’un signal faible ? Le décrire, vérifier, croiser les informations et adapter la surveillance.

Sources et portée

UE A1 CM2 NATURE ET QUALITE DES DONNEES RECUEILLIES PAR L.docx

Ressource Moodle correspondante